
QCM • CONCOURS

Concours de Recrutement des Infirmiers Diplômés d'Etat du Deuxième Grade - Session du 03 Mars 2012

Technicien de Radiologie

Specialite : Technicien de Radiologie

Annee : 2012

20 questions

Questions

1 Parmi les positions suivantes, laquelle correspond à celle du patient dans l'incidence du rachis lombaire en oblique anté/postérieur :

- | | |
|---|--|
| A | Malade debout, le côté opposé s'écarte du plan d'appui en faisant un angle 70° |
| B | Malade debout, le côté opposé s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° à 45° |
| C | Malade debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° à 45° |
| D | Malade debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° |

2 Parmi les critères de réussite suivants, lequel ne correspond pas au cliché de l'incidence de face du rachis cervical :

- | | |
|---|---|
| A | Position médiane de la ligne des épineuses |
| B | Position médiane de la trachée |
| C | L'axe sagittal passe le milieu de l'odontoïde et de l'épine de l'axis |
| D | Position symétrique du maxillaire inférieur |
| E | Bonne visibilité des espaces intervertébraux |

3 Lequel des centrages correspond à celui de l'incidence du coccyx de face en décubitus :

- | | |
|---|--|
| A | R.D incliné de 20° à 30° vers les pieds sur la symphyse pubienne |
| B | R.D incliné de 20° à 30° vers les têtes sur la symphyse pubienne |
| C | R.D incliné de 10° à 20° vers la tête sur la symphyse pubienne |
| D | R.D incliné de 10° à 20° vers les pieds sur la symphyse pubienne |

4 Pour dégager les arcs postérieurs des côtes, le patient prend la position :

- A Face en antéro-postérieure
- B Oblique en antéro-postérieur
- C Face en postéro-antérieur
- D Oblique en postéro-antérieur

5 Pour dégager les arcs moyens des côtes, le patient prend la position :

- A Face en antéro-postérieur
- B Oblique en antéro-postérieur
- C Face en postéro-antérieur
- D Oblique en postéro-antérieur

6 On désigne par les fausses côtes :

- A Les 6^{ème}, 7^{ème}, 8^{ème}, 9^{ème}, et 10^{ème} côtes
- B Les 7^{ème}, 8^{ème}, et 9^{ème} côtes
- C Les 7^{ème}, 8^{ème}, 9^{ème}, 10^{ème} et 11^{ème} côtes
- D La 11^{ème} et 12^{ème} côtes

7 Pour explorer l'omoplate de face :

- A On soulève l'épaule non à radiographier à un angle de 20°
- B On soulève l'épaule à radiographier d'un angle de 45°
- C On soulève l'épaule à radiographier d'un angle de 20°
- D On soulève l'épaule non à radiographier d'un angle de 45°

8 Pour explorer le bec Olécrânien, on centre :

- A 3 à 4cm au dessous de l'apophyse coronoïde
- B 3 à 4cm au dessus de la pointe de l'olécrane
- C Sur la pointe de l'olécrane
- D 3 à 4cm au dessous de la pointe de l'olécrane

9 Lesquels des critères de réussite suivants correspondent aux critères de réussite de l'incidence de coude de face :

- A Sommet de l'olécrane au milieu de la fossette coronoïdienne
- B L'interligne cubito-humérale visible
- C Sommet de l'olécrane au milieu de la fossette olécrânienne
- D L'interligne condyle-tête radiale visible

10 En radioprotection, la justification est une :

- A Réduction des écrans
- B Elimination des utilisations inutiles
- C Réduction des champs d'irradiation
- D Réductions de l'intensité des sources
- E Eloignement de la source

11 Le dosimètre :

- A Permet de vérifier le niveau d'exposition du personnel soumis à un risque d'irradiation
- B Un même dosimètre peut être utilisé par plus d'une personne
- C Permet de détecter des doses élevées provenant d'une situation incidente elle
- D Doit être porté seulement par les médecins radiologues et les techniciens de RX

12 Le cliché d'abdomen sans préparation (A.S.P) de face couché avec rayon vertical permet de :

- A Voir des lithiases radio opaques
- B Un adénome prostatique
- C Un épanchement gazeux intra abdominal
- D Des images hydroaériques
- E Des calcifications

13 La présence d'images hydroaériques sur un A.S.P debout avec R.H est secondaire à :

- A Une cholécystite aigue
- B Une occlusion mécanique
- C Un ileus biliaire
- D Un trouble de résorption (Diarrhée)

14 Le cliché pulmonaire en incidence de Muller (décubitus latéral) :

- A Est moins irradiant
- B Réalisé chez les patients en mauvais état général
- C Mobiliser un épanchement pleural
- D Facilite le diagnostic de la tuberculose
- E Nécessite un portique vertical

15 Sur le cliché pulmonaire de face en expiration forcée :

A	Les clavicules sont asymétriques
B	Les coupoles diaphragmatiques sont hautes
C	Les bases pulmonaires sont surexposées
D	Le médiastin est élargi
E	Voir un pneumothorax

16 Le sulfate de baryum :

A	Contre indiqué en cas de suspicion de perforation
B	Toujours associé à la gastrografine
C	Contre indiqué en cas d'occlusion par invagination intestinale chez le nourrisson
D	Ne nécessite pas de préparation digestive
E	Occasionne des allergies

17 La gastrografine :

A	Est utilisée exclusivement par voie orale
B	Son Z est inférieur à celui du baryum
C	Elle peut provoquer des phénomènes de diarrhées
D	Elle est inoffensive pour le péritoine
E	Peut être associée au sulfate de baryum

18 Le reflux gastroesophagien est recherché par :

A	Un A.S.P
B	Sous scopie
C	Des obliques
D	A la station verticale de profil estomac plein
E	Un Trendelenburg à 60°

19 L'injection intraveineuse ou artérielle d'iode est contre indiquée absolument en cas :

A	Asthme
B	Enfant de moins de 3kg de poids
C	Allergie à la pénicilline
D	Insuffisance rénale à 0,70g/l d'urée
E	Antécédents d'allergie grave à l'iode

20 La compression urétérale est contre indiquée :

A	En cas d'hématurie
B	Lithiase vésicale
C	Adénome prostatique
D	Anévrysme de l'aorte abdominale
E	Colopathie

Notes d'extraction

- Question 26 from original source paper omitted due to insufficient options.